指導医向け・30 分

CBE / EPA

コンピテンシー基盤型教育とEPA -- 「点数」から「できること」へ

参考文献

2026-03-24 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

導入の問い

USMLE（米国医師国家試験）で高得点の研修医が、必ずしも「良い医師」になるとは限らない。-- では、何で評価すればいいのか？

この30分の後、あなたは：

- CBE = Competency-Based Education（コンピテンシー基盤型教育）の基本概念を説明できる
- EPA = Entrustable Professional Activity（任せられる専門的活動）とマイルストーン評価を理解できる
- 自分の指導・研修にCBEの要素を1つ取り入れる計画を立てられる

試験の点数は何を予測するのか？

指標	事実	意味
USMLE Step 1 高得点	研修中のパフォーマンスとの関連は領域や指標により一貫せず、単独の物差しとしては限られる（系統的レビュー、2023）	知識 ≠ 能力
クラークシップの最上位評価	授与される学生の割合は米国の医学部間で2%～93%と大きくばらつく（2009-10年度、119校）	基準が曖昧
筆記試験	「知っている」を測るが「できる」を測らない	評価方法の不整合

「試験に受かる力」と「患者を診る力」は別物。このギャップを埋めるのがCBE。

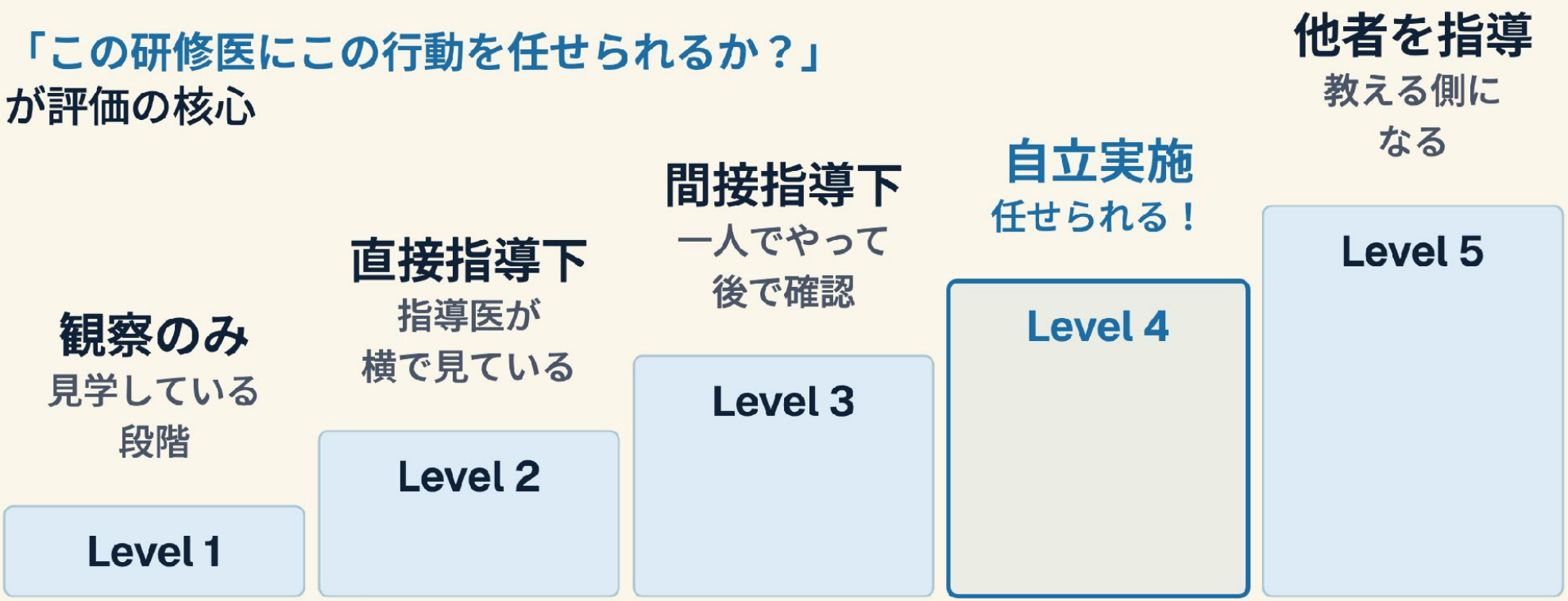
CBE（コンピテンシー基盤型教育）とは何か

	従来の教育	CBE
評価基準	時間（何年間研修したか）	能力（何ができるようになったか）
測定方法	筆記試験・口頭試験	EPA（実際の信頼レベル）＋ マイルストーン
指導者の役割	試験官・評価者	コーチ・伴走者
ゴール	合格ラインを越える	一人前の医師として任せられる

CBE ＝「何年研修したか」ではなく「何ができるようになったか」で評価する仕組み

EPA --「任せられる」を段階的に評価する

「この研修医にこの行動を任せられるか？」
が評価の核心



EPA = Entrustable Professional Activity（任せられる専門的活動）

「評価者」から「コーチ」へ

	従来の指導医	CBEのコーチ
スタンス	「できなかったこと」を指摘	「できるようになったこと」を確認
フィードバック	年に1-2回の総括評価	日常的な短い対話
目的	合否判定	成長支援
関係性	上下関係	伴走・協働

「あの先生は厳しい」と言われる指導医から、「あの先生がいると安心」と言われるコーチへ。

日本での動き(1)制度と研修

- 総合診療専門医を含む新専門医制度は2018年4月に始まった(日本専門医機構)。EPAの導入範囲は施設や領域で異なり、全国統一の運用は確認できていない(2026年11月時点)
- 初期研修の到達目標と評価は2020年度に改訂された(厚生労働省)。EPAそのものではないが、「できること」で評価する方向にある

日本での動き（2）試験と評価

- USMLE Step 1は2022年1月26日以降の受験分から、点数でなくPass/Failのみの報告になった
- OSCE（客観的臨床能力試験）は、「知っている」でなく「できる」を測る評価として医学教育に組み込まれている

「点数で評価」から「任せられるかで評価」への転換は、日本でも少しずつ進んでいる

ディスカッション

4分間 → 全体共有 2分

あなたの研修現場で、「点数では測れないが、医師として重要な能力」は何か？それをどう評価すればいい？

明日からの1アクション

- 研修医の「できること」を1つ、EPAのLevelで評価してみる
- 「できなかったこと」ではなく「できたこと」をフィードバックする
- 「次はこれを任せてみようか」という対話を、1回してみる